

УДК 616.42-006.6-097

Р. К. Каракулов

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Применение режима Ритуксимаб плюс СНОР при агрессивных неходжкинских лимфомах

Аннотация. Представлены результаты лечения 45 больных с агрессивной формой НХЛ, получивших 6-8 курсов ПХТ по схеме R-CHOP14 в качестве первой линии терапии у больных рефрактерной формой ДККВЛ. Полная ремиссия зарегистрирована опухоли у 82,1 + 7,2 %, частичная - у 18,0 + 2,2 %, прогрессирование процесса не зарегистрировано. В контрольной группе СНОР 21 (n=40) число больных с полной ремиссией опухоли составляет 70,0 + 8,4 %, частичной - 17,0 + 6,8 %, прогрессирование имело место у 13,0 + 6,2 % больных. За 3 года наблюдения смертность в основной группе не была зарегистрирована.

Ключевые слова: гематология, агрессивная НХЛ, ритуксимаб, рефрактерность, выживаемость.

За последние десятилетия отмечается значительный рост заболеваемости неходжкинскими лимфомами (НХЛ) во всем мире. Она выше в развитых странах, самая высокая заболеваемость (6,8-16,6‰) отмечается в США, Канаде, Великобритании и Европе, а низкая (2,9-4,1‰) – в Ю.Америке, Китае, Индии, России и Казахстане [3, 10, 7], [IARC -2012]. В РК заболеваемость гемобластозами составляет 8,0 на 100 тыс., занимает 8 ранговую позицию, а смертность 4,4‰ [4]. Согласно современной классификации International Lymphoma Study Group и ВОЗ, НХЛ представляют собой большую группу гематологических заболеваний, характеризующихся разнообразными гистологическими, иммунологическими, молекулярно-генетическими и клиническими проявлениями. Диффузная В-клеточная крупноклеточная лимфома (ДВККЛ) - агрессивная опухоль, составляющая 30-40% всех новых случаев НХЛ и обладающая наибольшей встречаемостью - до 80% [5]. Эффективность лечения больных с первично-резистентной опухолью или с рецидивами после адекватной ХЛТ значительно ниже. Разработанные для лечения этих больных многочисленные режимы второй линии, включающие цитостатики, не имеющие перекрестной резистентности с препаратами первой линии (СЕР, СЕМ, dexamethasone, mini-BEAM, DHAP) позволяют добиться ремиссии у 30-50% пациентов, однако 5-летняя безрецидивная/бессобытийная выживаемость не превышает 10-30%.

Известно, что агрессивные формы злокачественных лимфом (ЗЛ), высоко чувствительные к химиотерапевтической терапии. В то же время у 25-35% пациентов отмечаются рецидивы после начала лечения. Пятилетняя общая выживаемость у больных с ДККЛ III-IV стадии после комбинированного лечения (6 циклов ПХТ по схеме СНОР+лучевая терапия на крупные очаги поражения) составляет всего 65,0%. При ДККЛ В-клеточной лимфоме пятилетняя выживаемость при низкой степени риска равна 72,0%, а при высокой - всего 22,0% [1,2,6].

В литературе отмечается корреляция между злокаче-

ственностью опухоли и теломеразной активностью (ТА) опухолевых клеток. [8,11,9]. С целью определения степени агрессивности и возможных рецидивов нами была изучена теломеразная активность опухолевого субстрата НХЛ.

Особое значение при лечении НХЛ придается использованию моноклональных антител (МКА). Первым анти-CD20(+) МКА стал препарат ритуксимаб. В нескольких исследованиях добавление мабтеры к режиму СНОР позволили добиться полной ремиссии у 75% больных.

Целью нашего исследования

явилось улучшение результатов лечения с применением режима R-CHOP 14 у больных с агрессивной формой неходжкинских лимфом.

Дизайн исследования

Методом информированного согласия пациентов и рандомизации проводилось исследование (n=45) с агрессивной формой НХЛ II-IV А и В стадий заболевания.

Критерии включения: мужчины и женщины возрасте от 18 до 75 лет включительно, гистологический подтвержденный диагноз, включая данные ИГХ исследования. У пациентов должны наблюдаться II-IV стадия заболевания по классификации Анн-Арбор, показатель общего состояния здоровья пациента по шкале Восточной объединенной группы онкологии (ECOG) должен составлять от 0 до 2 баллов.

В контрольной группе наблюдались 40 пациентов НХЛ высокой степени злокачественности, получавшие ПХТ по схеме R-CHOP 21.

Распределение больных с НХЛ по гистологическому типу: ДВККЛ 25 больных, фолликулярная III тип- 5 больных, Т и В-клеточная - 5 больных, мантийной зоны - 7 больных и периферическая Т-клеточная форма - 3 больных.

У 20 больных из 45 зарегистрировано поражение периферических лимфоузлов выше и ниже диафрагмы, у 6-х медиастинальных, у 10-х – забрюшинных и подвздошных, у 4-х – легких и у 2-х-левой орбиты глаз и у 3-х - головного мозга.

Согласно Международному прогностическому индексу (IPI) 55,4% больных были отнесены к неблагоприятной прогностической группе.

Научная новизна: установлена достаточно высокая эффективность модернизированного режима R-CHOP 14 по сравнению с режимом R-CHOP 21 у пациентов с агрессивной формой неходжкинских лимфом.

Лечение проводилось с применением режима R-CHOP 14 (ритуксимаб по 350 мг/м², 0 день циклофосфамид 750 мг/м², доксорубин 50 мг/м², винкристин 1,4 мг/м², все 1 день, преднизалон 40 мг/м² 1-5 дни), цикл повторяется

через каждые 14 дней. Всего проведено 6-8 курсов ПХТ. Контрольную группу эквивалентную основной составила (n=40) пациентов с НХЛ II-IV A и B стадиями процесса, получавших ПХТ по той же схеме и по той же дозировке, но без ритуксимаба. Всего проведено 6-8 курсов.

Эффективность лечения оценивалась по степени регрессии опухоли и 4-летней общей и безрецидивной выживаемости.

Результаты лечения и их обсуждение

В основную группу вошли 45 больных с агрессивной формой НХЛ, из них мужчин составило 20, женщин – 25 больных, средний возраст составил 45 лет, в I-II стадию вошли 20, а II-III-25 пациентов. В контрольной группе наблюдались 30 пациентов, из них мужчин составило 10, женщин-20 человек, средний возраст пациентов составил 48 лет, I-II стадий заболевания составили 10, II-III ст.-20 больных.

Как следует из таблицы в основной группе (R-CHOP14) зарегистрирована полная ремиссия опухоли у 82,0±7,2 % больных, частичная ремиссия – у 18,0±2,2%, прогрессирование процесса в основной группе не было установлено. Контрольную группу включили 30 больных, получавших ПХТ по схеме R-CHOP 21. Число больных достигших полной ремиссии опухоли составила 70,0±8,4%, частичной-17,0±6,8%, прогрессирования имело место у 13,0±6,2% больных ($p > 0,05$). Ряд авторов (Поддубная И.В. с соавт., 2005) [] указали на преимущество режима R-CHOP 14 над режимом R-CHOP 21 при проведении 8 циклов ПХТ. Однако, следует заметить, что проведенное EORTC (MinT) рандомизированное исследование 824 молодых больных с низким риском из 18 стран (Pfreundschuh, 2004) показало преимущество схемы R-CHOP и R-CHOP подобных режимов с последующей лучевой терапией на крупные и экстранодальные очаги над такой же схемой лечения молодых больных с хорошим прогнозом без применения ритуксимаба. Убедительно продемонстрировано преимущество схемы R-CHOP у пожилых больных с ДВКЛ. Оказалось, что в группе больных старше 60 лет, получавшие R-CHOP безрецидивная выживаемость составила 53%, против 46% в группе CHOP. Интенсификация схемы R-CHOP во времени (R-CHOP14) у пожилых больных ДВКЛ приводила к таким же отдаленным результатам лечения как при схеме R-CHOP 21 (Pfreundschuh, 2004).

Преимущество режима R-CHOP 21 было показано в исследованиях Нечунаевой И.Н. с соавт.[3] при применении его в качестве первой и второй линии терапии у больных с ДВКЛ.

Таблица - Результаты лечения больных с агрессивной формой НХЛ

Кол-во больных	Полная ремиссия, %	Частичная ремиссия, %	Прогрессир. процесса, %
Основная группа (n=45)	82,0±7,2	18,0±2,2	0,0
Контр. группа (n=30)	70,0±8,4	17,0±6,8	13,0±6,2

Анализ кривой выживаемости показывает, что 4-летняя общая выживаемость в основной группе составила 90%, в контрольной группе (R-CHOP 21) – 59,0%. Анализ безрецидивной выживаемости показал, что у пациентов, получавших ПХТ по схеме R-CHOP14 таковая составила 85,0%, против 47,0% у пациентов, получавших ПХТ с интервалом 3 недели.

Оценка общего состояния больного (Performance status) по шкале Карновского и ECOG – ВОЗ показала в обеих ос-

новных группах до лечения таковое составило в пределах 40,0- 50,0% (3 балла), а после лечения (6-8 циклов) у всех пациентов отмечается улучшение такого указанного показателя составляют, соответственно 80,0-90,0% (1 балл).

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что применение модернизированной схемы R-CHOP 14 у пациентов с агрессивной формой НХЛ существенно повышает эффективность лечения на 12% (полная ремиссия) по сравнению с контрольной, не вызывая существенного токсического действия на организм пациентов. Кроме того, режим R-CHOP 14 улучшает 4-летнюю общую и безрецидивную выживаемость пациентов. Токсичность препаратов была выражена умеренной степени. Общее состояние больных по ECOG оценивалось как 1 балл.

Список литературы

1. Короленко В.О., Гершанович М.П., Тихонова В.В. Трехлетние результаты применения препарата Мабтера (Ритуксимаб) в лечении индолентных неходжкинских лимфом, резистентных к стандартной химиотерапии // Вопросы онкологии. - 2004. - Т.50, №4. - С. 421-425.
2. Лорие Ю.Ю.. Лимфома из клеток мантийной зоны / Онкогематология.-2006.- Т.8, №1.-С.1-6.
3. Нечунаева И.Н., Агеева Т.А., Маслова Л.М. и др. Эффективность лечения диффузных В-крупноклеточных лимфом по данным городского гематологического центра г.Новосибирска // Бюлл. СО РАМН.-2011.-Т.31, №2.-С.71
4. Поддубная И.П. Обоснование лечебной тактики при неходжкинских лимфомах // Современная онкология.-2002.-Т.4, №1.-С.3-7.
5. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Байпейсов Б.М. и др. Показатели онкологической службы Республики Казахстан за 2011 год. - Алматы, 2012.
6. Строжаков Г.И., Хайленко В.А., Шерстнев В.М. Клинические особенности диффузной В-крупноклеточной лимфомы у больных, инфицированных вирусами гепатита С и В // Онкогематология.-2010.-№1.-С.49-57.
7. Bassegio L., Salles G., Dupire S. et. all. Decreased B and T cell repertoire diversities are associated with infectious risk in diffuse large B cell lymphoma (DLBCL) patients//17th congress European Hematology Association. - Amsterdam, 2012. - С. 110.
8. Globocan 2008 (IARC).-2012.
9. Hiya K. et. all. Telomerase activity in small-cells and non-small-cells lung cfncers// J.Natl . CancerInst.-2004/-Vol.87/-C/895.
10. Sommerfeld H.J. et all. Telomerase activity, a prevalent marker of malignant human prostate tissue // Cancer Res.-2008.-Vol.56.-C.18.
11. Stein H., Warnke R.A., Chan W.C. et.all. Diffuse large B-cells lymphoma, not otherwise specified // WHO Classification of Tumors of Haemotopoetic and Lymphoid Tissues, 4th Ed.-Lyon, 2008.
12. Guel A., Risso A., Ruella M. Telomerase loss is an early and persistent abnormality in leucocytes from patients treated with conventional chemotherapy but not from those exposed to Rituximab alone // 17th Congress European Hematology Association. - Amsterdam, 2012.
13. Urawsky N., Held G., Zeinalova S. et all. Improved outcome of elderly DLBCL patients with 6XCHOP-14 and 8 Rituximab applications given over an extended period (smarte-RCHOP-14 dshnhl trial) is due to better results of male patients //17th Congress European Hematology Association. - Amsterdam, 2012.

Тұжырым

Р.К. Каракулов

Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ

Агрессивті Ходжкинді емес лимфома кезінде ритуксимаб плюс CHOP режимін қолдану.

Агрессивті Ходжкин емес лимфоманың турақты түрімен ауыратын 45 науқасты R-CHOP14 кестес бойынша емдеу нәтижес келтірілген. Толық ремиссия 82,1±7,2% жартылай ремиссия - 18,0±2,2%

науқастарда байқалды. Екінші салыстармалы топта бұл нәтижелер мыныдай болды- 70,0+-8,4 және 17,0+-6,8%, науқастың асқынуы 13,0+-6,2% байқалды.

Түйінді сөздер: гематология, агрессивті ХЕЛ, ритуксимаб, рефрактерлігі, өміршеңдік.

Summary

R.K.Karakulov.

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology

Application mode Rituximab Plus CHOP for aggressive non-Hodgkin lymphoma

. The results of treatment of 45 patients with an aggressive

form of NHL who received 6-8 courses PCTs scheme R-CHOP 14 as first-line therapy in refractory forms bolnyhs DLBCL. Complete remission of the tumor was registered at 82.1 + 7.2%, in part - from 18.0 + 2.2%, progression of the process is not registered. In the control group 21 CHOP (n = 40) Number of patients with complete remission of the tumor is 70.0 + 8.4%, partial - 17.0 + 6.8%, the progression occurred in 13.0 + 6.2% of patients . Over the 3-year follow-mortality in the study group was not registered.

Keywords: hematology, aggressive NHL, rituximab refractory survival.